

PAUSE CARDIO

Nouveautés de la semaine du 19 septembre 2026

4 nouveautés cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Méta-analyse

Ultrashort vs Standard-Duration Dual Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndrome Patients Undergoing PCI: A Meta-Analysis.

JACC: Cardiovascular Interventions · 14 septembre 2026 · Méta-analyse de 10 essais randomisés, 29 232 patients

Cette méta-analyse de 10 essais randomisés, soit 29 232 patients traités par angioplastie pour un syndrome coronarien aigu, compare une bithérapie antiplaquettaire ultracourte (un mois ou moins) relayée par une monothérapie et une bithérapie de durée standard. La bithérapie ultracourte n'a pas augmenté, dans l'ensemble, les événements cardiaques et cérébrovasculaires majeurs (HR 1,06 ; IC95 % 0,93–1,20) ; elle a réduit les saignements majeurs (HR 0,47 ; IC95 % 0,35–0,64) et a apporté un bénéfice clinique net (HR 0,83 ; IC95 % 0,72–0,97). Deux réserves cependant : un signal d'excès d'événements ischémiques dans le STEMI, absent dans le SCA sans sus-décalage, et un surcroît d'événements cardiaques et cérébrovasculaires quand le raccourcissement est le plus intensif (bithérapie d'une semaine ou moins, ou monothérapie par clopidogrel ou aspirine).

En pratique : après angioplastie pour un syndrome coronarien aigu, ces données vont dans le sens d'une bithérapie raccourcie à un mois, qui fait moins saigner sans excès d'événements ischémiques dans l'ensemble. Les analyses en sous-groupes suggèrent de réserver ce raccourcissement aux schémas d'au moins deux semaines de bithérapie relayée par ticagrelor ou prasugrel : une bithérapie d'une semaine ou moins, ou un relais par clopidogrel ou aspirine, pourrait augmenter le risque ischémique. Le signal d'excès d'événements ischémiques dans le STEMI invite à la prudence chez ces patients, et la réduction des saignements, plus marquée chez les patients d'Asie de l'Est, rappelle que l'ampleur du bénéfice peut différer d'une population à l'autre.

[Article original](#)

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Méta-analyse

Intracoronary Imaging-Guided Percutaneous Coronary Intervention: An Updated Meta-Analysis of Randomized Trials.

JACC · 10 septembre 2026 · Méta-analyse de 28 essais randomisés, 24 634 patients

Cette méta-analyse actualisée réunit 28 essais randomisés, soit 24 634 patients suivis 22 mois en moyenne. Ces essais comparent l'angioplastie guidée par imagerie intracoronaire (échographie endocoronaire ou tomographie par cohérence optique) et l'angioplastie guidée par la seule angiographie, à l'ère des stents actifs. Le guidage par imagerie réduit l'échec de la lésion cible (RR 0,72 ; IC95 % 0,61–0,85), la mortalité cardiaque (RR 0,73 ; IC95 % 0,58–0,91) et la mortalité totale (RR 0,82 ; IC95 % 0,70–0,96), ainsi que l'infarctus, la revascularisation du vaisseau cible et la thrombose de stent. Les différences entre essais s'expliquent surtout par la région géographique et les caractéristiques des lésions traitées.

En pratique : malgré quelques essais récents sans bénéfice, l'ensemble des données randomisées reste en faveur du guidage par imagerie intracoronaire, avec une réduction des événements, y compris de la mortalité. Ce résultat va dans le sens de l'indication de classe I des recommandations pour les lésions complexes et le tronc commun. Pour le cardiologue qui adresse un patient, c'est un argument pour demander si le centre d'angioplastie dispose de l'imagerie intracoronaire, en particulier devant une lésion complexe.

[Article original](#)

Efficacy and Safety of Semaglutide According to Frailty Status: A Post Hoc Analysis of the SELECT Randomized Clinical Trial.

JAMA Cardiology · 16 septembre 2026 · Analyse post hoc de l'essai SELECT, 17 604 patients

L'essai SELECT a comparé le sémaglutide 2,4 mg hebdomadaire et le placebo chez 17 604 adultes en surpoids ou obèses ($\text{IMC} \geq 27$), sans diabète, ayant une maladie cardiovasculaire établie. Cette analyse post hoc classe ses participants selon un index de fragilité à 31 items : 31 % ne sont pas fragiles, 47 % ont une fragilité intermédiaire et 22 % sont les plus fragiles. L'effet du sémaglutide sur le critère principal (décès cardiovasculaire, infarctus ou AVC non fatals) ne diffère pas de façon détectable entre les trois catégories (p d'interaction = 0,09) ; il en va de même de la réduction de l'insuffisance cardiaque, des hospitalisations et de la mortalité. Le gain de qualité de vie est plus important chez les plus fragiles, et l'excès d'arrêts pour effets indésirables, par rapport au placebo, diminue à mesure que la fragilité augmente.

En pratique : chez le patient en surpoids ou obèse avec maladie cardiovasculaire, la fragilité ne semble pas réduire le bénéfice du sémaglutide ni en dégrader la tolérance, et la qualité de vie s'améliore davantage chez les plus fragiles. Ces données plaident pour ne pas écarter un patient de ce traitement au seul motif de sa fragilité, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une analyse post hoc, qui ne permet pas de conclure pour les patients les plus dépendants.

[Article original](#)

Whole-grain consumption and cardiometabolic risk: a meta-analysis of randomized trials.

European Heart Journal · 15 septembre 2026 · Méta-analyse de 87 essais randomisés sur des facteurs de risque

Cette méta-analyse de 87 essais randomisés (101 publications) estime l'effet des céréales complètes sur les facteurs de risque cardiométabolique, par tranche de 48 g par jour en poids sec, soit environ 90 g en poids frais ou trois portions. Chaque tranche s'accompagne d'une baisse du poids ($-0,20$ kg), du tour de taille, du cholestérol total ($-0,10$ mmol/L) et de l'interleukine-6, avec un niveau de preuve élevé. Elle abaisse aussi, avec un niveau de preuve modéré, le LDL-cholestérol, les triglycérides, la glycémie à jeun et la pression artérielle systolique ($-0,82$ mmHg). Les effets les plus marqués sont observés autour de 60 à 100 g par jour. Il s'agit d'effets sur des marqueurs, pas sur des événements cliniques.

En pratique : les essais randomisés montrent que les céréales complètes améliorent, modestement mais de façon constante, le poids, les lipides et la pression artérielle, avec les effets les plus marqués vers 60 à 100 g par jour, sans qu'un seuil ferme puisse être fixé. C'est un argument mesuré pour les recommander dans le conseil nutritionnel, sans en attendre plus qu'un effet modeste sur les marqueurs, et sans preuve directe, à ce jour, d'un effet sur les événements cliniques.

[Article original](#)